PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Composição corporal no praticante de exercício

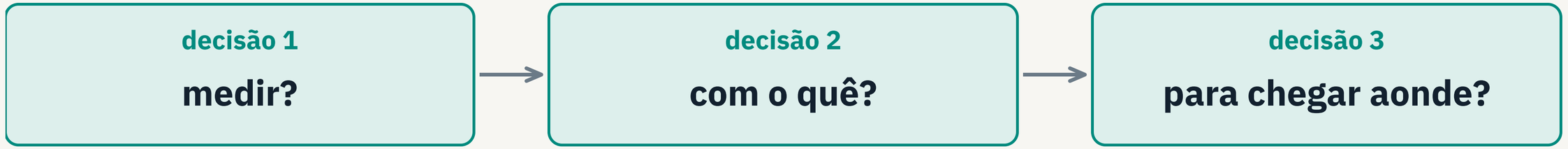
Indicação, métodos e definição de metas

Nutrição Esportiva

A ÚNICA MEDIDA DO MÓDULO QUE PODE MACHUCAR

O número muda comportamento antes de mudar conduta

antes: o que a pessoa quer saber?



Quem pede a bioimpedância quase sempre pergunta outra coisa: estou perdendo músculo? Está funcionando? Eu estou bem? Força, desempenho e uma conversa respondem melhor.

DECISÃO UM

Só meça se houver uma decisão dependendo do número

Medir tem indicação

- categoria de peso
- restrição com risco de perder massa magra
- recomposição em treino de força
- doença: sarcopenia, obesidade em tratamento

Não medir de rotina

se cruzar, vence

- transtorno alimentar, atual ou passado
- relação alterada com corpo e comida
- adolescente
- baixa disponibilidade energética

> Resultado alto e resultado baixo levam à mesma conduta? Não meça. As colunas se cruzam? A da direita vence.

DECISÃO DOIS · DUAS REVISÕES, 2012 E 2015

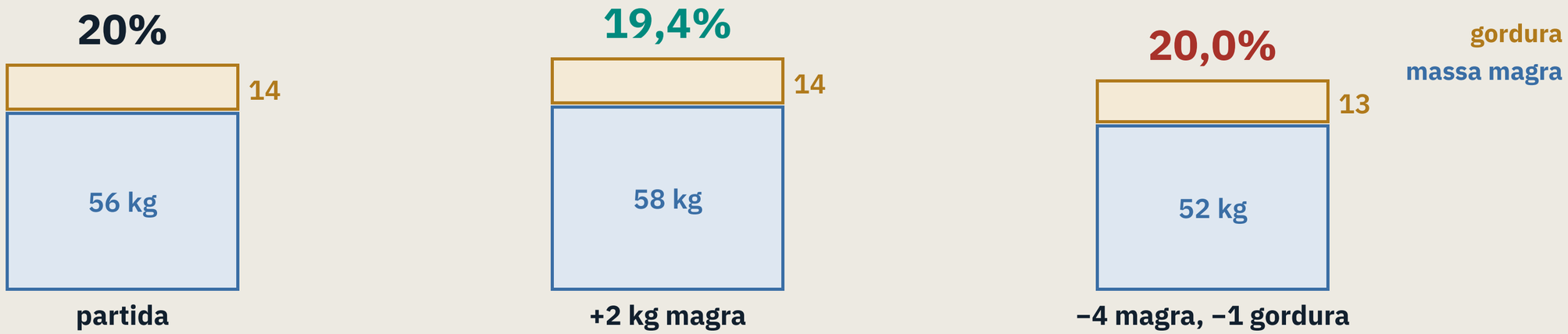
Todo método tem erro. Qual você aceita?

Método	O que domina o erro	Para que serve
Bioimpedância	a água do corpo	só com padronização rigorosa
Dobras cutâneas	quem mede	a mesma pessoa, avaliador treinado
DXA	protocolo e aparelho	massa magra por região
Cintura	quase nada, se padronizada	risco cardiometabólico
Índice de massa corporal	não separa músculo de gordura	população, não indivíduo

> A massa livre de gordura da conta de disponibilidade energética vem de um destes métodos, e carrega o erro dele.

Ackland e colaboradores · Sports Medicine 2012 · Nana e colaboradores · International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2015

O percentual é uma razão



Somatório de dobras em milímetros; DXA em quilos. O medido engana menos que o calculado: 68 mm é dado, 18,2% é equação.

Conta ilustrativa

SE FOR MEDIR, MEDIR DIREITO

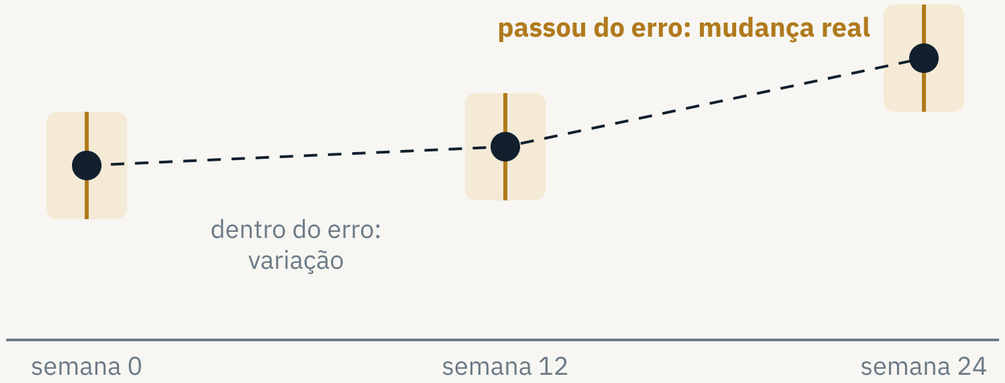
Uma série, não números soltos

Padronizar e anotar

- mesmo horário, de manhã; mesmo jejum
- hidratação habitual; nada depois de treino ou sauna
- sem treino intenso no dia anterior
- mesma fase do ciclo; mesmo avaliador e aparelho

Ler a mudança

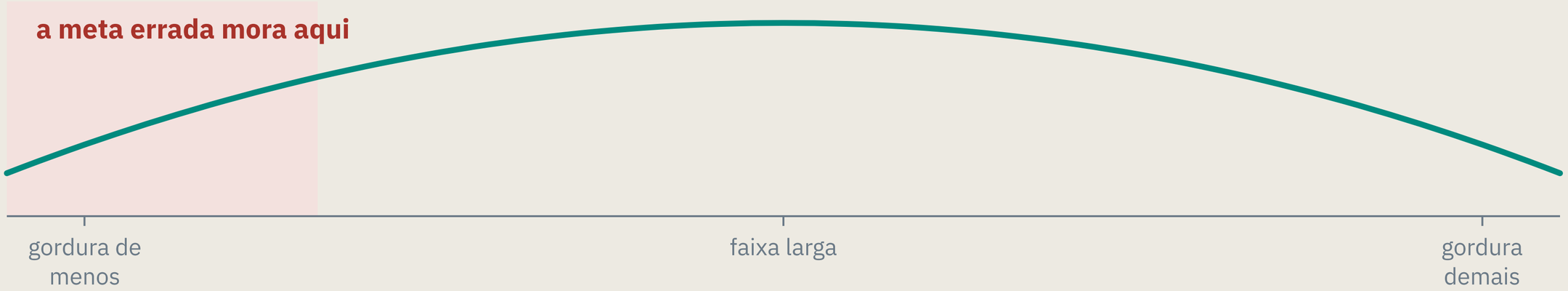
não mais que a cada doze semanas · faixas: erro do método, esquema



> Medir todo mês produz custo, ilusão de precisão e ansiedade. Nenhuma das três é conduta.

DECISÃO TRÊS

A meta errada quase sempre olha para baixo



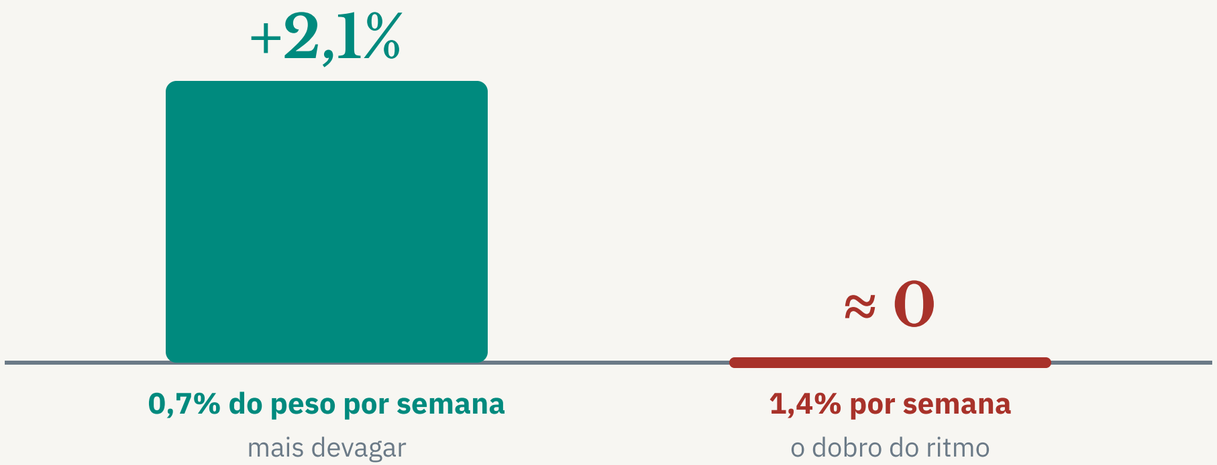
Três portas: a foto (números de poucos dias), a crença (menos gordura, sempre mais desempenho) e o método (meta construída sobre ruído).

Esquema, sem valores medidos

UM ENSAIO DE 2011

Mais devagar preservou o que importava

mudança da massa magra



0,7% por semana em 70 kg

≈ 500 g

por semana

Meta numérica pede faixa, prazo, ritmo e freios: desempenho que cai, ciclo que some, fratura por estresse, humor e sono piores, comida ocupando o dia.

Garthe e colaboradores · 24 atletas de elite, 4 sessões de força por semana · International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2011

Quatro regras de linguagem

Sem adjetivo

~~alto~~

~~ruim~~

~~ótimo~~

número com contexto e margem

Sem elogio automático

~~“Parabéns, baixou!”~~

a redução pode ter vindo de restrição

O erro em voz alta

“Uma diferença pequena pode ser só variação.”

Ancorar no que importa

- força
- desempenho
- sintoma
- ciclo

> “Eu tenho o número e posso te mostrar. Mas ele não responde à sua pergunta. O que responde é isto aqui.” E a mesma frase em todas as salas.

TRÊS PERFIS TÍPICOS

A mesma pergunta, três respostas

Perfil	Medir?	Com o quê	A meta
Lutadora 62 kg, −4 kg em 6 semanas	✓ sim, após triagem	dobras ou DXA, em mm e kg	**≈ 1,1% por semana: rever o prazo**
Em medicação para obesidade força caindo	✓ sim	DXA e teste de função	**gordura, preservando músculo**
Rapaz com o papel da academia restrição e culpa	✗ não	—	**regularidade e relação com a comida**

> Desidratar para a pesagem não é composição corporal: é água, com risco real. Ninguém da equipe ensina.

A REGRA PARA TODOS

Medir quando houver decisão

- Só meça quando o resultado mudar a conduta
- Acompanhe o medido, com protocolo, a cada doze semanas no máximo
- Devolva sem adjetivo, e desconfie da meta que só olha para baixo

Nutricionista

Meta e plano alimentar.

Educador físico

A carga que decide o que se perde.

Médico

Medicação, sarcopenia, critério de interrupção.

Quando o número dispara restrição, o psicólogo entra junto com o médico.